
RECOMMANDER
LES BONNES PRATIQUES

GUIDE

ALD 23 – Troubles anxieux graves*

Actes et prestations affection de
longue durée

Validé par le Collège le 23 janvier 2025

* Le périmètre de ce document correspond aux troubles anxieux tels que définis par la CIM 10 (cf. Critères médicaux d'admission en vigueur) et le DSM IV : le trouble anxieux généralisé, le trouble panique avec ou sans agoraphobie, le trouble anxiété sociale, la phobie spécifique, le trouble obsessionnel compulsif et l'état de stress post traumatique.

Cette actualisation (la précédente version date de 2017) de l'APALD « troubles anxieux graves » a porté sur les éléments suivants :

Sur la forme :

- Actualisation des textes relatifs aux affections de longue durée.
- Ajustement des objectifs du présent document.
- Insertion d'un avertissement en début d'APALD précisant ce qu'est et ce que n'est pas un document APALD.
- Simplification de la présentation des indications d'intervention des professionnels, des indications des actes techniques et des traitements.

Sur le fond :

- Limitation du contenu de l'APALD aux actes et prestations pris en charge par l'Assurance Maladie.
- Suppression des éléments qualitatifs suivants : ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, fréquence de réalisation des actes et prestations.
- Professionnels :
 - Ajout du pédiatre, de l'IPA, du chirurgien-dentiste, de la sage-femme.
 - Suppression du psychologue.
- Biologie :
 - Ajout de l'hémogramme, de la magnésémie, des beta-HCG.
 - Suppression de la créatininémie avec estimation de la clairance de la créatinine.
- Traitements :
 - Les médicaments sont déplacés dans un paragraphe distinct.
 - Suppression du traitement des phénomènes de dépendance, de la psychothérapie.
 - L'éducation thérapeutique fait l'objet d'un court paragraphe d'information en fin de document.
- Annexe :
 - Suppression de la pregabaline.
- Médicaments (y compris vaccins) :
 - Création d'un chapitre distinct.
 - Ajout de l'alprazolam, du bromazepam, du clobazam, du clorazépate dipotassique, du clotiazépam, du diazépam, du loflazépate d'éthyle, du lorazépam, de l'oxazépam, du prazépam, de l'hydroxyzine, de la cyamémazine, et du sulpiride.
 - Suppression du propranolol.

Descriptif de la publication

Titre	ALD 23 – Troubles anxieux graves* Actes et prestations affection de longue durée
Méthode de travail	
Objectif(s)	
Cibles concernées	
Demandeur	
Promoteur(s)	Haute Autorité de santé (HAS)
Pilotage du projet	
Recherche documentaire	
Auteurs	
Conflits d'intérêts	Les membres du groupe de travail ont communiqué leurs déclarations publiques d'intérêts à la HAS. Elles sont consultables sur le site https://dpi.sante.gouv.fr . Elles ont été analysées selon la grille d'analyse du guide des déclarations d'intérêts et de gestion des conflits d'intérêts de la HAS. Les intérêts déclarés par les membres du groupe de travail ont été considérés comme étant compatibles avec leur participation à ce travail.
Validation	Version du 23 janvier 2025
Actualisation	janv. 2025
Autres formats	

Ce document est téléchargeable sur www.has-sante.fr 

Haute Autorité de santé – Service communication information
5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00
© Haute Autorité de santé – janvier 2025

Sommaire

1.	Avertissement	5
2.	Critères médicaux d'admission en vigueur	6
3.	Professionnels impliqués dans le parcours de soins	8
4.	Biologie	9
5.	Actes techniques et activités de télésurveillance médicale	10
6.	Médicaments (y compris les vaccins)	11

Mise à jour des actes et prestations ALD (APALD)

Les actes et prestations ALD (APALD) sont actualisés régulièrement et disponibles sur le site Internet de la HAS (www.has-sante.fr)

1. Avertissement

Contexte Affection de longue durée (ALD)

Les ALD sont des affections nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse pour lesquelles la participation des assurés peut être limitée ou supprimée pour les actes et prestations nécessités par le traitement (article L. 160-14 3° du Code de la sécurité sociale modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 -art. 47).

En cas d'ALD, « le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 » (article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale).

Missions de la HAS en matière d'ALD

Conformément à ses missions, [définies aux articles L. 161-37 1° et art. R. 161-71 3° du code de la sécurité sociale (CSS)], la Haute Autorité de santé formule des recommandations sur les actes et prestations nécessités par le traitement des affections mentionnées à l'article L. 324-1 pour lesquelles la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application du 3° et 4° de l'article L. 160-14 CSS.

Par ailleurs, elle :

- émet un avis sur les projets de décret pris en application du 3° de l'article L. 160-14 CSS fixant la liste des affections de longue durée ;
- formule des recommandations sur les critères médicaux utilisés pour la définition de ces mêmes affections ;
- formule des recommandations sur les actes médicaux et examens biologiques que requiert le suivi des affections relevant du 10° de l'article L. 160-14 CSS.

Contenu du document actes et prestations ALD

Ce document comporte les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, selon les règles de droit commun. Ainsi les utilisations hors AMM, hors LPPR, hors LATM n'y apparaissent pas.

Les actes et prestations liés à la prise en charge des effets indésirables des traitements et des comorbidités n'y sont pas développés. L'adaptation du protocole de soins à la situation de chaque patient relève du dialogue entre le malade, le médecin traitant et le médecin conseil de l'assurance maladie.

L'APALD n'est pas une recommandation de bonne pratique. Il ne constitue pas une aide à la décision portant sur la stratégie diagnostique ou thérapeutique.

L'APALD est un outil médico-administratif pour l'élaboration du protocole de soins lors de l'admission en ALD ou son renouvellement. C'est une synthèse réglementaire des actes, soins et traitements remboursables, nécessaires au diagnostic, traitement et suivi de l'ALD ou à son renouvellement.

2. Critères médicaux d'admission en vigueur

(Décrets nos 2011-74-75-77 du 19 janvier 2011 et no 2011-726 du 24 juin 2011 et no 2017-472 du 3 avril 2017 et no 2024-768 du 8 juillet 2024)

Ce document « Actes et prestations affections psychiatriques de longue durée, troubles anxieux graves » ne concerne que le chapitre d) des critères médicaux d'admission : troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement, au sein desquels seuls les troubles anxieux graves sont traités.

ALD 23 « affections psychiatriques de longue durée » (Extrait)

Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à l'exonération du ticket modérateur : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.

1° Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :

[...]

d) Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement :

Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :

- troubles anxieux graves ;
- états limites ;
- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, schizoïde, dyssoziale ;
- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale) ;
- troubles addictifs graves ;
- dysharmonies évolutives graves de l'enfance.

L'exonération du ticket modérateur est limitée aux formes de troubles mentaux avec manifestations sévères, notamment :

- pour les manifestations de type hystérique : les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
- pour les manifestations de type obsessionnel : l'envahissement par des conduites compulsives ou par des rites contraignants, et la présence de modes de pensée paralysants relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
- pour les manifestations de type phobique : l'étendue des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques et les phases prolongées de sidération relèvent de l'exonération du ticket modérateur ;
- pour les manifestations anxieuses : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts et l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir relèvent de l'exonération du ticket modérateur.

2° L'ancienneté de cette affection :

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les affections dont l'ancienneté est supérieure à 1 an au moment de la demande. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.

3° Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux) :

Les affections relevant de l'exonération du ticket modérateur sont celles ayant des conséquences fonctionnelles majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable pour les [...] d [...].

3. Professionnels impliqués dans le parcours de soins

Bilan initial	
Professionnels	Situations particulières
Médecin généraliste	Tous les patients
Psychiatre	
Recours selon les besoins	
Pédopsychiatre	Selon besoins
Pédiatre	Selon besoins
Autres médecins spécialistes	Selon besoins
Traitement et suivi	
Professionnels	Situations particulières
Médecin généraliste	Tous les patients
Psychiatre	
Recours selon les besoins	
Pédopsychiatre	Selon besoins
Pédiatre	Selon besoins
Gynécologue obstétricien	Selon besoins
Gériatre	Selon besoins
Médecin interniste	Selon besoins
Médecin ayant une compétence en addic- tologie	Selon besoins
Autres médecins spécialistes	Selon besoins
Infirmière, IPA	Selon besoins
Chirurgien-dentiste	Selon besoins
Sage-femme	Selon besoins

4. Biologie

Examens	Situations particulières
Ionogramme sanguin	Selon besoins
Hémogramme y compris plaquettes	Selon besoins
Fonctions hépatiques : SGOT, SGPT, gamma-GT	Selon besoins
Glycémie	Selon besoins
Exploration d'une anomalie lipidique	Selon besoins
Créatininémie et estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) avec l'équation CKD-EPI	Selon besoins
Magnésémie	Selon besoins
Beta-HCG (sang ou urines)	Selon besoins

5. Actes techniques et activités de télésurveillance médicale

Actes	Situations particulières
Électrocardiogramme (ECG)	Bilan initial, suivi selon traitement

6. Médicaments (y compris les vaccins)

Médicaments ¹	Situations particulières
Anxiolytiques	
Benzodiazépines : – Alprazolam – Bromazépam – Clobazam – Clorazépate dipotassique – Clotiazépam – Diazépam – Loflazépate d'éthyle – Lorazépam – Oxazépam – Prazépam	Selon besoins. AMM pour les manifestations anxieuses.
Hydroxyzine	Selon besoins. AMM pour les manifestations mineures de l'anxiété chez l'adulte.
Buspirone	Selon besoins. AMM pour l'anxiété généralisée.
Antidépresseurs	
Inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine :	Selon besoins. AMM pour :
– Citalopram	– Prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie
– Escitalopram	– Trouble panique, trouble anxiété généralisée, troubles obsessionnels compulsifs
– Fluoxétine	– Troubles obsessionnels compulsifs
– Fluvoxamine	– Troubles obsessionnels compulsifs
– Paroxétine	– Trouble panique, trouble anxiété généralisée, troubles obsessionnels compulsifs, trouble anxiété sociale, état de stress post-traumatique
– Sertraline	– Trouble panique, troubles obsessionnels compulsifs, trouble anxiété sociale, état de stress post-traumatique
Venlafaxine	Selon besoins. AMM pour le trouble anxiété généralisée.
Duloxetine	Selon besoins. AMM pour le trouble anxiété généralisée.
Clomipramine	Selon besoins. AMM pour les troubles obsessionnels compulsifs, la prévention des attaques de panique.

¹ Les guides mentionnent généralement une classe thérapeutique. Le prescripteur doit s'assurer que les médicaments prescrits appartenant à cette classe disposent d'une indication validée par une autorisation de mise sur le marché (AMM).

Médicaments ¹	Situations particulières
Antipsychotiques	
Cyamémazine	Selon besoins. AMM pour le traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété de l'adulte en cas d'échec des thérapies habituelles.
Sulpiride	Selon besoins. AMM pour le traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété de l'adulte en cas d'échec des thérapies habituelles.
Autres	
Hypnotique	Selon besoins

Éducation thérapeutique

Les séances d'éducation thérapeutique du patient ne sont pas listées car elles ne sont pas remboursées à l'acte par l'Assurance Maladie, mais elles peuvent être prises en charge dans le cadre d'hospitalisation, de réseau de soins.

Retrouvez tous nos travaux sur
www.has-sante.fr

